

Escopo do projeto

1-

Ator	Etapa	O que faz no sistema	Regra que existe
Recepção	1. Chegada	Buscar o paciente pelo CPF	Sempre antes de cadastrar, para não duplicar o paciente
Recepção	1. Chegada	Cadastrar o paciente com os dados pessoais	Só se a busca pelo CPF não encontrar ninguém. CPF não pode se repetir
Recepção	1. Chegada	Alterar os dados pessoais do paciente	—
Recepção	1. Chegada	Abrir um atendimento para o paciente	O número (AT0001) é gerado pelo sistema, nunca digitado, e não se repete
Recepção	1. Chegada	Consultar um atendimento	Permitido em qualquer situação, inclusive depois da confirmação do médico
Recepção	1. Chegada	Alterar um atendimento	Só enquanto o médico não confirmou
Recepção	1. Chegada	Cancelar um atendimento, informando o motivo	Só enquanto o médico não confirmou
Enfermagem	2. Triagem	Ver a lista de atendimentos aguardando triagem	Aparecem só atendimentos abertos, nunca cancelados
Enfermagem	2. Triagem	Registrar pressão arterial, temperatura e batimentos cardíacos	—
Enfermagem	2. Triagem	Registrar as principais queixas do paciente	—
Enfermagem	2. Triagem	Classificar o atendimento pelo Protocolo de Manchester	Só a enfermagem classifica. Sem classificação, o atendimento não entra no painel do médico

Enfermagem	2. Triagem	Reclassificar o atendimento se o quadro do paciente mudar	Só enquanto o médico ainda não acessou o atendimento
Médico	3. Atendimento	Ver o painel de atendimentos aguardando	A ordem segue a classificação de Manchester. O médico vê a classificação, mas não pode alterá-la
Médico	3. Atendimento	Acessar um atendimento, vendo os dados do paciente e da triagem	Só atendimentos já triados
Médico	3. Atendimento	Registrar as medicações (nome, dose, via, frequência e duração)	Só no atendimento que ele acessou e ainda não confirmou
Médico	3. Atendimento	Registrar orientações para o paciente	Só no atendimento que ele acessou e ainda não confirmou
Médico	3. Atendimento	Confirmar o atendimento e registrar a alta	Depois de confirmado, o atendimento sai do painel e nenhum ator pode mais alterar ou cancelar

2-

Assunto	Campos	Finalidade
Paciente	Nome completo, data de nascimento, CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, endereço e telefone*.	Nome, documentos e filiação auxiliam na identificação; o nascimento permite calcular a idade; o endereço registra a residência e o telefone permite contato.
Atendimento	Número (AT0001), paciente, confirmação médica, data e hora de chegada*, situação* e data e hora da confirmação*.	O número identifica a visita e o paciente indica a quem ela pertence. A chegada registra sua ordem; a situação acompanha as etapas; a confirmação e seu horário permitem controlar o cancelamento.
Triagem	Pressão arterial, temperatura corporal, batimentos cardíacos, principais queixas, classificação de Manchester, data e hora* e profissional responsável*.	Os sinais e as queixas registram a avaliação; a classificação define a prioridade na fila; data, hora e responsável identificam quando e por quem ela foi feita.
Medicação	Nome da medicação, dose e unidade*, via de administração*,	Identificar o medicamento, a quantidade, a forma de administração, os intervalos e

	frequência*, duração*, atendimento correspondente* e médico responsável*.	o período de uso. Atendimento e médico vinculam a indicação à visita e ao responsável.
Encerramento	Data e hora da alta*; data, hora e motivo do cancelamento*, quando aplicável.	Registrar quando o atendimento terminou ou quando e por que foi cancelado.

3- O Protocolo de Manchester

1. Classificações do protocolo (cor e nome)

O Protocolo de Manchester (Manchester Triage System – MTS) utiliza **cinco níveis de prioridade**, cada um associado a uma cor:

Cor	Nome / Nível de urgência
Vermelho	Emergência / Immediate
Laranja	Muito urgente / Very urgent
Amarelo	Urgente / Urgent
Verde	Pouco urgente / Standard
Azul	Não urgente / Non-urgent

2. Significado de cada classificação e tempo máximo de espera

- **Vermelho (Emergência):** risco iminente de morte ou condição que exige intervenção imediata. Tempo máximo: **0 minutos** (atendimento imediato).
- **Laranja (Muito urgente):** condição grave com risco significativo de deterioração rápida. Tempo máximo: **10 minutos**.
- **Amarelo (Urgente):** condição que requer atenção médica em prazo intermediário, sem risco imediato de morte. Tempo máximo: **60 minutos**.
- **Verde (Pouco urgente):** condição estável de baixa gravidade que pode aguardar sem prejuízo clínico relevante. Tempo máximo: **120 minutos** (2 horas).
- **Azul (Não urgente):** situação de mínima gravidade, frequentemente resolvível em outros níveis de atenção. Tempo máximo: **240 minutos** (4 horas).

Esses tempos são os **máximos recomendados** até o primeiro contato com o médico. Ultrapassá-los exige reavaliação.

3. Como isso vira ordenação no painel do médico

No painel do médico a fila é ordenada **estritamente por prioridade clínica (cor)**, não por ordem de chegada:

1. Vermelho (topo absoluto)
2. Laranja
3. Amarelo
4. Verde
5. Azul (base)

Pacientes de cor mais urgente sempre aparecem acima dos de cor menos urgente, independentemente do horário de triagem.

4. Fonte

- Manchester Triage Group (Emergency Triage, 3ª edição – Mackway-Jones, Marsden & Windle).
- Síntese consolidada a partir de fontes clínicas e institucionais que descrevem o MTS original e sua aplicação no Brasil (ex.: materiais de referência do Grupo Brasileiro de Classificação de Risco e descrições padronizadas utilizadas em serviços do SUS).
- Consulta realizada em 27 de setembro de 2026.

Regra adotada pelo grupo para empate de mesma cor (decisão da Parte 6)

Regra: quando dois ou mais pacientes estão classificados na **mesma cor** e aguardam há tempo equivalente, o painel ordena por **ordem cronológica de triagem** (primeiro triado → primeiro na fila daquela cor).

Motivo: o Protocolo de Manchester não define critério de desempate. Adotar a ordem de triagem (FIFO dentro da mesma prioridade) é a regra mais simples, transparente, auditável e justa, evitando discricionariedade e facilitando a implementação no sistema.

4 -

De	Para	Quem dispara	Regra
Não iniciado	Aberto	Recepção	Ao abrir o atendimento, o sistema gera automaticamente um número único para identificar a visita do paciente.
Aberto	Aguardando triagem	Recepção	Apenas atendimentos abertos e não cancelados entram na lista da enfermagem.
Aguardando triagem	Aguardando médico	Enfermagem	A enfermagem registra os sinais vitais, as principais queixas e a classificação de Manchester. Sem classificação, o atendimento não entra no painel médico.
Aguardando médico	Aguardando médico	Enfermagem	A reclassificação é permitida caso o quadro do paciente mude, desde que o médico ainda não tenha acessado o atendimento.
Aguardando médico	Em atendimento	Médico	O médico acessa o atendimento já triado e visualiza os dados do paciente e da triagem, sem poder alterar a classificação de Manchester.
Em atendimento	Em atendimento	Médico	O médico registra as medicações e orientações enquanto o atendimento ainda não foi confirmado.
Em atendimento	Confirmado / Alta	Médico	O médico confirma o atendimento e registra a alta. Após a confirmação, o atendimento sai do painel e

			não pode mais ser alterado ou cancelado.
Aberto	Cancelado	Recepção	O cancelamento é permitido antes da confirmação médica, mediante registro do motivo.
Aguardando triagem	Cancelado	Recepção	O atendimento pode ser cancelado antes da confirmação médica, mediante registro do motivo.
Aguardando médico	Cancelado	Recepção	Mesmo após a triagem, o cancelamento é permitido enquanto não houver confirmação médica, mediante registro do motivo.
Em atendimento	Cancelado	Recepção	O cancelamento é permitido enquanto o médico não confirmar o atendimento, mediante registro do motivo.
Cancelado	Cancelado	Sistema	Estado final. O atendimento não retorna ao fluxo e permanece registrado para consulta.
Confirmado / Alta	Confirmado / Alta	Sistema	Estado final. O atendimento permanece disponível para consulta, sem possibilidade de alteração ou cancelamento.

5-

Entidade	Relacionamento	Entidade	Lido em português
Paciente	1:N	Atendimento	Um paciente pode ter vários atendimentos ao longo do tempo, e cada atendimento pertence a um único paciente.
Atendimento	1:1	Triagem	Cada atendimento tem no máximo uma triagem, e cada triagem pertence a um único atendimento.
Atendimento	1:N	Medicação	Um atendimento pode ter várias medicações prescritas, e cada registro de medicação corresponde a um único atendimento
Atendimento	1:1	Encerramento	Cada atendimento pode ter no máximo um encerramento, e cada encerramento corresponde a um único atendimento.

6-

Dúvida	Decisão	Motivo
O código de atendimento é gerado automaticamente		

pelo sistema ou a recepcionista precisa informar um código?	O sistema deve gerar automaticamente um código único para cada atendimento baseado na categoria dos pacientes.	Evita códigos repetidos e reduz o trabalho da recepcionista.
O código de atendimento é criado no cadastro do paciente ou somente quando ele inicia um atendimento/consulta?	O código deve ser gerado quando o paciente inicia um atendimento no pronto-socorro.	Um paciente pode retornar várias vezes e precisa ter um código diferente para cada atendimento.
Um paciente que já está cadastrado precisa ser cadastrado novamente quando retornar ao pronto-socorro?	A recepcionista deve buscar o paciente pelo seu identificador antes de realizar um novo cadastro.	Evita duplicidade e mantém o histórico do paciente.
Quem pode definir ou alterar a prioridade do paciente?	Apenas a enfermeira deve poder definir e editar a prioridade. O médico apenas visualiza.	Agiliza a consulta feita pelo médico e trata com mais rapidez quem precisa de um atendimento mais urgente.
A prioridade pode ser alterada depois de definida?	Permitir que a enfermeira altere a prioridade caso o estado do paciente mude.	A prioridade pode precisar ser atualizada durante a permanência do paciente caso seu quadro mude.
O médico consegue visualizar apenas a prioridade ou também os dados da triagem?	O médico deve visualizar a prioridade e as informações registradas na triagem.	As informações da triagem ajudam o médico durante a consulta e complementam a prioridade.
As medicações e as orientações dadas pelo médico ao paciente devem ficar registrada no prontuário do paciente?	Sim, a prescrição deve ser vinculada ao atendimento e ao prontuário do paciente.	Permite manter o histórico do atendimento e das medicações e orientações prescritas
O paciente terá algum acesso ao sistema ou apenas será cadastrado pelos funcionários?	O perfil do paciente poderá ser acessado somente pelos funcionários do pronto-socorro.	Para garantir a privacidade e a segurança dos dados pessoais e médicos do paciente.
O perfil do paciente será apenas para visualização ou permitirá editar informações?	O perfil do paciente permitirá a edição de informações pelos funcionários do pronto-socorro.	Para evitar que informações importantes do paciente sejam alteradas incorretamente ou sem autorização.

ID	Entregável	Feito quando	Parte	Ator	Tam.
E1	Tela de cadastro do paciente	A recepcionista cadastra um paciente com os dados obrigatórios e ele fica disponível no sistema para acompanhamento da consulta.	Front	Recepção	P
E2	Cadastro do paciente	O sistema salva os dados do paciente no banco de dados, impedindo CPF duplicado.	BD	Recepção	M
E3	Função de geração do código do paciente	Ao realizar o cadastro ou abrir um atendimento, o sistema gera um código de atendimento único para identificar a consulta.	Back	Recepção	M
E4	Tela de triagem	A enfermeira registra as informações necessárias da triagem do paciente, permitindo que os dados sejam utilizados durante o atendimento médico.	Front	Enfermagem	P
E5	Registro da triagem	O sistema recebe e armazena os dados da triagem vinculados ao paciente e ao atendimento.	Back	Enfermagem	M
E6	Tela de prioridade (edição)	A enfermeira define e pode alterar o grau de prioridade do paciente de acordo com a necessidade de atendimento.	Front	Enfermagem	G
E7	Atualização da prioridade	O sistema salva a prioridade definida pela enfermeira e a associa ao atendimento correto.	BD	Enfermagem	M
E8	Tela de prioridade (visualização)	O médico visualiza o grau de prioridade definido para cada paciente para identificar a ordem de atendimento.	Front	Médico	P
E9	Consulta da prioridade	O sistema recupera a prioridade registrada para o paciente e disponibiliza a informação ao médico.	Back	Médico	G
E10	Tela do prontuário do paciente	O médico acessa o prontuário, registra a medicação prescrita e adiciona orientações para o tratamento do paciente.	Front	Médico	P
E11	Registro do prontuário	O sistema salva as informações de medicação e orientações vinculadas ao paciente.	BD	Médico	M
E12	Tela de consulta	O médico confirma a realização da consulta e registra a alta do paciente, permitindo o encerramento do atendimento.	Front	Médico	P

E13	Perfil do paciente	Funcionário autorizado visualiza os dados do paciente.	Front	Funcionário	P
E14	Consulta do perfil do paciente	O sistema busca no banco os dados do paciente e seu histórico e disponibiliza essas informações para visualização.	Back	Funcionário	M

8-

Quantas semanas: 11 semanas.

Integrantes	Horas por semana
Angelina Durigan	3 horas
Felipe Ribeiro Paulo	5 horas
Maria Fernanda	8 horas
Ricardo Borges	5 horas
Samantha Esteves	6 horas
Théo M.	8 horas
Total do grupo, por semana	35 horas

35 horas por semana x 11 semanas = 385 horas-pessoas

Tamanho	Quantos itens	Horas
P(8h)	6	48
M(20h)	6	120
G(40h)	2	80
Total	14	248

Temos 385 horas-pessoa e o escopo pede 248. Cabe, com folga de 137 horas para imprevisto.

9 -

Repositorio: <https://github.com/mariarodriguesds/pi2-2026-2-0102-grupo02>

Card no OpenProject: https://srv1889234.hstgr.cloud/projects/pi-ii-0102-g2/work_packages/172/activity

Integrantes:

Angelina Durigan	@angelinadurigan
Felipe Ribeiro Paulo	@blaston
Maria Fernanda Marques Rodrigues	@mariarodriguesds
Ricardo Verissimo Borges	@RicoBorgesPack
Samantha Dell Vecchio Esteves	@Samantha Dell Vecchio Esteves
Théo Monteiro Olino Noia Agunso	@theomont7